

Tabla de resumen de medicamentos utilizados para sedoanalgesia y bloqueo neuromuscular

NOMBRE DEL MEDICAMENTO	SOLVENTES COMPATIBLES PARA DILUCIÓN	VOLUMEN DE DILUCIÓN	ESTABILIDAD SOLUCIÓN DILUÍDA	TIPO DE ADMINISTRACIÓN	OBSERVACIONES	DOSIS
Atracurio	S.F 0.9% S.G 5%	CVC: hasta 5mg/1ml(500 mg/100 ml) VVP: hasta 2.5 mg/1ml (250mg/100 ml)	24 hrs a temperatura ambiente	EV directa: SI EV intermitente: SI EV continua: SI	Estabilidad según solvente: una solución de 0,5mg/mL es estable por 8 h en SG5% y 24 hr en SF 0,9%	Bolos: 0,4-0,5 mg/kg. Intermitente: 0,08-0,1mg/kg c/20-45 min. Continua: 5-15 µg/kg/min
Bromuro de rocuronio	S.F 0.9% SG 5% SRL	0,5 - 2 mg/ml	24 horas a temperatura ambiente y expuestos a la luz ambiental	EV directa: SI EV intermitente: NO EV continua: SI IM: SI Otras vías: NO	Este medicamento no debe mezclarse con otros medicamentos Reducir la dosis en función del peso corporal magro en pacientes obesos	5-15 µg/kg/min
Dexmedetomidina	S.F 0.9% S.G 5% SRL	-1000 µg/250CC -Frasco viene 400µg en 100ml	24 horas a temperatura ambiente y expuestos a la luz ambiental	EV directa: NO EV intermitente: NO EV continua: SI	Este medicamento puede provocar bradicardia e hipotensión. No deprime la respiración. No administrar en bolo	0,4 a 1,4 µg/kg/Hr

Diazepam	SF 0.9% SG 5%	No es recomendado Se puede diluir 1mg/ml	6 Hrs a Temperatura ambiente si esta diluido. Proteger de la luz.	EV directa: SI EV intermitente: NO EV continua: SI IM: SI Otras vías: V.O., V.R	Flumazenil invierte el efecto de benzodicepinas en caso de sobredosis, no se recomienda Infusión Continua, debido a la precipitación de líquidos.	0,1 - 0,4 mg/kg/dosis. Dosis máxima 20 mg/dosis
Etomidato	No diluir	No diluir	Usar inmediatament e después de abrir	EV directa: SI EV intermitente: NO EV continua: NO	No usar en dosis prolongadas. Alto riesgo de flebitis tras su uso. Poco o nulo efecto hemodinamico	0,2 a 0,3 mg/Kg Administrar en 30-60 segundos

Fentanilo	SF 0.9% SG 5%	2000µg/100ml (2mg/100ml) 4000 µg/100ml (4mg/100ml)	Temperatura ambiente. 24 hrs	EV directa: SI EV intermitente: SI EV continua: SI IM: SI Otras vías: parche intradérmico	La sobredosis es revertida con Naloxona	0.5-4.0 µg/Kg/Hr
Flumazenil	SF 0.9% SG 5%	Bolo: No diluir Intermitente: 0.5mg/50ml	Temperatura ambiente Proteger de la luz.	EV directa: SI EV intermitente: NO EV continua: SI IM: NO Otras vías: NO	Se pueden presentar síntomas de privación en pacientes en tratamiento prolongado con benzodicepinas. En este caso, adm 5mg de Midazolam vía IV lenta	Reducción de sedación inducida por benzodicepinas: Dosis inicial: 0.2mg c/15 Seg. Seguida de intervalos de 1min por dosis de 0.1-0.2mg de ser necesario. Dosis usual: 0.3-0.6mg. Sobredosis por benzodicepinas: 0.2mg IV en 30seg. De ser necesario, dosis adicional de 0.3mg a los 30seg, a intervalos de 1min, dosis de 0.5mg, hasta una dosis total de 3-5mg

Haloperidol	SF 0.9% SG 5%	Bolo: No diluir Infusión intermitente: 5-10 mg en 100 ml. Infusión continua: 50 mg en 50 ml	24 Hrs a Temperatura ambiente en SG5%. 8 Hrs a Temperatura Ambiente en SF	IM: SI EV directa: SI EV intermitente: SI EV continua: SI	Puede generar hipotensión por excesiva sedación.	Agitación y Psicosis Aguda: dosis inicial de 2-10 mg IM (Máx. inicial 18 mg), se puede administrar cada 4-8 Hrs. Pacientes con disturbios severos podrían requerir dosis sobre 30 mg, seguidos de dosis de 5 mg. Antiemético: 0.5-2 mg/día (IM)
Ketamina	SF 0.9% SG 5%	Infusión continua: 1G/250ml Concentración máxima de 4mg/1ml	24 hrs a temperatura ambiente	IM: SI EV directa: SI EV intermitente: SI EV continua: SI	Para reducir la incidencia de reacciones al despertar, se administra Diazepam u otra benzodiacepina antes de la intervención o como adyuvante de la Ketamina	5-30 µg/kg/min
Ketoprofeno	SF 0.9% SG 5% SRL	Bolo: 1ml en 10ml Infusión: 10ml en 500ml	En suero fisiológico 24 horas.	EV directa: NO EV intermitente: SI EV continua: NO IM: SI Otras vías: V.O.	La administración directa (en bolo) puede provocar flebitis y dolor en sitio de inyección, es muy venoiritante. Reduce o revierte los efectos de muchos antihipertensivos	100-300 mg/día 20 – 30 minutos
Ketorolaco	SF 0.9% SG 5%	En 50-100 ml Concentración máxima de 6 mg/ml.	Estable por 48 horas. Protegido de la luz	IM: SI EV directa: SI EV continua: SI EV intermitente: NO	30mg de ketorolaco equivalen a 12 mg de morfina o meperidina. Utilizar con precaución en pacientes con daño renal o falla hepática.	IM: 60 mg, en una dosis o 30 mg cada 6 Hrs. IV: 30 mg, una dosis o 30 mg cada 6 Hrs. Paciente crítico (IM, IV): 30 mg una vez, seguido de 15-30 mg cada 6 Hrs, durante un máximo de 5 días.
Lorazepam	SF 0.9% SG 5%	Diluir solo en	Estable por 24 hrs a temperatura ambiente	EV directa: si EV intermitente: no	Puede causar: paro cardíaco, hipotensión, bradicardia, colapso	Ansiedad: 1-4 mg. Insomnio asociado con ansiedad: 1-2 mg

	SRL	caso de infusión continua 1mg/1ml		EV continua: si IM: SI Otras vías: V.O.	cardiovascular, confusión, disnea, ataxia, amnesia, flebitis, dolor en el sitio de inyección, visión borrosa o doble, depresión respiratoria, laringoespasmo y, con uso prolongado, dependencia física.	Pre-medicación para anestesia: IM: 0,05 mg/Kg, administrado 2 Hrs antes de la cirugía (máximo 4 mg). IV: 0,044 mg/Kg administrado 15-20 min antes de la cirugía (dosis usual: 2 mg, máximo 4 mg). Estado Epiléptico: IV: 4 mg administrados lentamente (máximo 4mg/min), se puede repetir la dosis dentro de 5-10 min. IM: se puede utilizar, pero se prefiere IV. Agitación en UCI: dosis de carga 0,02-0,04 mg/Kg (dosis máxima 2 mg) Dosis de mantención: 0,02-0,06 mg/Kg/2-6 Hrs. Según sea necesario, o 0,01-0,1 mg/Kg/Hr.; dosis máxima 10 mg/Hr. Delirio por abstinencia de alcohol: IM, IV: dosis fija, 2 mg cada 6 Hrs, durante 4 dosis, luego 1m cada 6 Hrs. Durante 8 dosis adicionales.
Metamizol	SF 0.9 SG 5%	Bolo: 0.5g en 5cc Infusión intermitente: diluir en 50-100ml	Se protege de la luz en infusiones continuas de 24 horas	EV directa: NO EV intermitente: SI EV continua: SI IM: SI Otras vías: VO, VR (supositorio)	Se puede administrar la ampolla de metamizol EV vía oral para manejar el dolor	1-3 g/ 8 Hrs Dosis máxima 4g en 24hrs.
Midazolam	SF 0.9% SG 5%	100mg/100ml o concentración máxima de 5mg/1ml	Diluida: 24 horas.	EV directa: SI EV infusión intermitente: NO EV infusión continua: SI IM: SI Otras vías: V.O., endotraqueal	El antagonista es el Flumazenil.	Dosis de mantención: 0.015mg/kg/hr a 0.35mg/kg/hr
Morfina	SF 0.9% SG 5%	Bolo: 2.5 -15mg diluido en 5 o 10ml	A temperatura ambiente máximo 72 hrs.	EV directa: SI EV intermitente: NO EV continua: SI	precaución en pacientes con pancreatitis (causa espasmo del esfínter de Oddi).	Las dosis y los intervalos de dosificación deben titularse para el alivio del dolor / prevención.

		Infusión intermitente: 100mg por 100ml (1mg/ml). Rango: 0.1-1mg/ml Infusión continua: 100mg/50ml (2mg/ml) o en un rango 0.5-5mg/ml en caso de concentrar volumen		IM: SI Otras vías: S.C.	Naloxona es antagonista	10mg (rango: 5-20mg) cada 4Hr IM o SC, o 2.5-15mg cada 4Hrs IV. Después de la dosis de carga (15mg o más), adm una infusión continua de 0.8-80mg (hasta 150mg) por Hr
Naloxona	SF 0.9% SG 5%	Bolo: 400µg por 1ml Infusión continua: 2mg en 50ml (40µg/ml) o 2mg en 500ml	Estable 24 horas en suero fisiológico o suero glucosado al 5%	EV directa: SI EV intermitente: NO EV continua: SI IM: SI Otras vías: S.C., intraoseo	El fármaco revierte los efectos de los analgésicos narcóticos , por lo tanto se debe considerar administrar analgésicos no opioides para el tratamiento del dolor	Contrarrestar sedación: 2 mcg/kg/dosis, repetir después de 2 minutos. Antagonismo morfina: 10 mcg/kg/dosis (Max. 0,4 mg).
Petidina	SF 0.9% SG 5%	Infusión intermitente: diluir en 50-100ml	Es estable por 7 días a temperatura	EV directa: SI EV intermitente: SI EV continua: SI	La administración rápida puede producir un incremento en el riesgo	E.V: 0,5 - 1 mg/kg. I.M: 0,5 - 2 mg/kg. Infusion continua: 5 mg/kg en 50

		para obtener la concentración de 1mg/ml Bolo: máximo 10 mg/ml Infusión continua: 50 mg por 50 ml (1mg/ml)	ambiente y 14 días refrigerada.	IM: SI Otras vías: S.C.	de efectos adversos, principalmente depresión respiratoria, apnea, hipotensión	ml, 1 - 4 ml/hr (0,1 - 0,4 mg/kg/hr).
Propofol	----- -	----- ---	-----	EV directa: SI EV intermitente: NO EV continua: SI IM: NO Otras vías: NO	Agitar antes de usar, utilizar venas de calibre grande Cambiar bajadas de bomba cada 24 hrs. No mezclar con productos sanguíneos ni con otros medicamentos por la misma vía o en una mezcla.	Sedación: 1 - 3 mg/kg/hr (max 4mg/kg/hr), no más de 48 hr. Corto periodo de anestesia: 2,5 - 3,5 mg/kg, luego 7,5 - 15 mg/kg/hr.
Succinilcolina	SF 0.9% SG 5%	Bolo: no diluir 1 - 2 mg/ml (infusión continua).	24 Hrs Refrigerado	EV directa: SI EV intermitente: NO EV continua: SI (no recomendado) IM: SI Otras vías: NO	A 1 - 2 mg/ml en suero fisiológico es estable por 7 días a temperatura ambiente y 4 semanas refrigerado. Sin embargo, el proveedor recomienda no almacenar más allá de 24 horas el fármaco diluido, a temperatura ambiente (por	Inicialmente 20 a 100mg IV. Alternativamente, 0.3 a 1.1mg/Kg. La dosis puede ser repetida. Si no se puede acceder a la vía IV, administrar 2.5mg/Kg/dosis, IM

					estabilidad microbiológica)	
Esketamina	SF 0.9% SG 5% SRL	1mg/1ml	24 Hrs Refrigerado	EV directa: SI EV intermitente: NO EV continua: SI	Puede aumentar frecuencia cardiaca y presión arterial. Puede generar disociación. Puede aumentar secreción bronquial	0,1-0,3 mg/kg/Hr
Vecuronio	S.F 0.9% S.G 5%	CVC: (50 mg/50 mL) VVP: 20 mg/100 mL	24 Hrs Refrigerado	Directa: Sí Intermitente: Sí Continua: Sí	Evitar su uso en pacientes con daño renal debido a que se prolonga el tiempo del bloqueo neuromuscular.	Dosis de carga o inducción: 0,08-0,1 mg/kg Dosis de mantención: 0,8-1,2 mcg/kg/min

Referencias bibliográficas

-Clarke, B., & Davidson, I. (2011). Injectable drugs guide (3rd ed.). CRC Press.

- Rodríguez Villar, S. (2023). Handbook de fármacos: Urgencias, anestesia, críticos, coronarios (5.ª ed.). Marbán.

Utilizar esta tabla como una referencia para la preparación de los medicamentos, teniendo en cuenta que puede variar según el laboratorio que lo prepara.

Revisar siempre el prospecto antes de preparar los medicamentos. En caso de dudas consultar a un químico farmacéutico.

TENER PRESENTE SIEMPRE LOS 10 CORRECTOS

- Medicamento correcto
- Vía de administración

- Paciente correcto
- Dosis correcta
- Hora correcta
- Registro correcto
- Preparar usted mismo el medicamento
- Administrar usted mismo el medicamento
- Tener responsabilidad de la administración
- Razón correcta

Elaborado por: E.U Juan Mora C.